

NOTE SEO : Chaque fiche intègre un H1 optimisé avec mot-clé principal + localisation Tunis, une introduction servant de méta-description (150–160 mots), des requêtes longue traîne dans les titres et le corps, et une FAQ ciblant les featured snippets Google.

Interventions > Visage > Lifting cervico-facial

Visage

Lifting cervico-facial — Chirurgie du rajeunissement du visage Tunis

Le lifting cervico-facial est l'intervention de référence pour corriger les signes du vieillissement du bas et du milieu du visage : relâchement cutané, bajoues, perte de l'ovale, rides profondes, double menton, cou strié. Lorsque les soins esthétiques et la médecine injectable ne suffisent plus, le lifting permet de retrouver un visage reposé, rajeuni de 8 à 12 ans, sans modifier les traits ni effacer l'identité. Réalisé à Tunis sous anesthésie générale, c'est l'intervention la plus complète de la chirurgie esthétique du visage.

2–4h Durée	Générale Anesthésie	1–2 nuits Hospitalisation	3–6 mois Résultat définitif
----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LE LIFTING CERVICO-FACIAL ?

Le lifting cervico-facial agit sur les trois structures anatomiques responsables du vieillissement facial : la peau (redrapage et résection de l'excès), le SMAS — système musculo-aponévrotique superficiel (remise en tension en profondeur, fondation du résultat), et la graisse (redistribution ou lipoaspiration des zones en excès). Cette triple action garantit un résultat naturel et durable, là où un lifting purement cutané vieillirait mal.

Plusieurs techniques sont disponibles selon votre anatomie et vos besoins : le lifting deep plane (plan profond, résultats les plus naturels et les plus durables), le lifting SMAS, le lifting temporal, ou le lifting ponytail (minimal invasif, cicatrices dans les cheveux). Le choix est fait lors de la consultation après examen clinique.

Le lifting cervico-facial ne traite pas les rides du front ni les rides d'expression péri-orbitaires. Ces zones relèvent du lifting frontal ou de la médecine esthétique (toxine botulique, acide hyaluronique). Une blépharoplastie peut être associée dans le même temps pour un rajeunissement global du visage.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Relâchement cutané du bas et du milieu du visage — joues, bajoues, ovale affaissé
- Cou relâché avec fanons ou stries cervicales
- Plis nasogéniens et plis d'amertume marqués
- Double menton associé à un excès graisseux cervical
- Peau avec une élasticité résiduelle suffisante
- Bonne santé générale, sans tabagisme actif

Le lifting cervico-facial n'est pas indiqué en cas de tabagisme non sevré — le risque de nécrose cutanée est majeur. Il est également contre-indiqué en cas de pathologie cardio-vasculaire non

contrôlée, de troubles de la coagulation ou d'hypertension artérielle non équilibrée. Ces éléments sont évalués lors du bilan préopératoire.

03 LA CONSULTATION

La consultation comprend une analyse morphologique complète du visage debout et de profil : évaluation de la qualité et de l'élasticité cutanée, de l'épaisseur du tissu sous-cutané, de l'état du SMAS, de la projection du menton et des volumes de la face. Nous discutons ensemble de vos attentes, du type de lifting le mieux adapté à votre anatomie, et des gestes associés éventuels (blépharoplastie, lipofilling, lipoaspiration cervicale).

Je vous explique précisément le tracé des cicatrices — dissimulées dans le cuir chevelu temporal, au contour de l'oreille et derrière le pavillon — et leur évolution dans le temps.

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention. Un bilan biologique complet et une consultation anesthésique sont requis.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique complet (NFS, plaquettes, coagulation, groupe sanguin) et consultation anesthésique
- **Tabac** : Arrêt total du tabac au moins 1 mois avant et 1 mois après — exigence absolue
- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine, des anti-inflammatoires et de la vitamine E 10 jours avant
- **Contraception** : Arrêt de la contraception orale si possible 1 mois avant — à discuter avec votre médecin
- **Jeûne** : Jeûne strict à partir de minuit la veille
- **Cheveux** : Shampoing avant l'opération — les cheveux longs peuvent être attachés de façon à dégager le pourtour de l'oreille
- **Organisation** : Prévoir un accompagnateur pour le retour et une aide à domicile les premiers jours

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale et dure entre 2 et 4 heures selon l'étendue du geste et les techniques associées. L'incision est tracée dans la zone chevelue temporale, se prolonge naturellement dans le pli préauriculaire, contourne le lobe de l'oreille et remonte derrière le pavillon dans la zone rétroauriculaire — zones naturellement dissimulées.

Après décollement cutané, le SMAS est saisi, remodelé et remis en tension selon la technique choisie (plication, imbrication, ou dissection deep plane). Ce travail en profondeur est le garant de la durabilité et du naturel du résultat. L'excès cutané est ensuite réséqué avec précision, sans tension excessive — la peau est redrapée, non tirée. Une lipoaspiration cervicale est associée en cas de double menton.

La règle d'or du lifting naturel : ne jamais tirer la peau. La tension doit être portée par le plan musculo-aponévrotique profond, pas par le revêtement cutané. Un lifting trop tendu sur la peau donne le visage « tiré » que tout le monde veut éviter — et vieillit mal.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- 1 à 2 nuits en clinique selon l'étendue du geste
- Pansement compressif retiré le lendemain matin
- Accompagnateur obligatoire pour le retour
- Arrêt de travail de 2 à 3 semaines — vie sociale restreinte pendant 10 à 15 jours
- Conduite déconseillée pendant 10 jours
- Exposition solaire strictement évitée pendant 3 mois

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J3	Pansement compressif. Drains éventuels. Douleurs légères, sensation de tension. Tête surélevée.
Semaine 1–2	Ecchymoses et œdème importants mais attendus. Premier shampoing dès J2. Ablation des fils vers J7–J10. Maquillage possible dès J7.
Semaine 2–4	Régression progressive des ecchymoses. Sensation d'engourdissement cutané transitoire. Reprise de la vie sociale possible vers S2–S3.
Mois 1–3	Disparition de l'œdème résiduel. Le résultat commence à se révéler. Cicatrices en maturation.
Mois 3–6	Résultat définitif. Visage rajeuni, reposé, naturel. Cicatrices devenues imperceptibles dans leurs zones de dissimulation.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le résultat s'apprécie pleinement entre 3 et 6 mois, une fois l'ensemble de l'œdème résorbé et les tissus stabilisés. Le visage est rajeuni de 8 à 12 ans selon les cas : l'ovale est restauré, les bajoues effacées, le cou affiné et lissé. Le résultat est naturel — les traits sont préservés, le visage est reconnaissable.

La durabilité est de 8 à 12 ans selon la qualité cutanée, l'hygiène de vie et l'exposition solaire. Le vieillissement reprend son cours naturellement après l'intervention, sans accélération ni effet de rebond.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX	RISQUES SPÉCIFIQUES
– Hématome post-opératoire (prévention par drains) – Infection superficielle – Réaction anesthésique – Thrombose veineuse	– Nécrose cutanée partielle (tabac ++) – Paralysie faciale transitoire (nerf facial — rare) – Asymétrie résiduelle – Cicatrice élargie ou visible – Alopécie temporaire dans les zones de traction – Hypo-sensibilité cutanée (régresse en 3–6 mois) – Résultat insuffisant nécessitant une retouche

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

À quel âge peut-on faire un lifting cervico-facial ?

Il n'y a pas d'âge fixe. L'indication repose sur l'état du visage, pas sur l'âge civil. La plupart des lifting sont réalisés entre 45 et 65 ans, mais certaines morphologies ou histoires familiales justifient une intervention plus précoce ou plus tardive. C'est l'examen clinique qui décide.

Le résultat sera-t-il naturel ?

Oui, à condition que la technique soit la bonne. Un lifting bien réalisé donne un visage reposé et rajeuni — pas un visage « tiré ». La clé est de travailler en profondeur sur le SMAS plutôt que de tirer sur la peau. C'est le principe fondateur de ma technique.

Peut-on associer d'autres interventions au lifting ?

Oui. La blépharoplastie, le lipofilling, la lipoaspiration cervicale, le lip lift ou la génioplastie peuvent être associés dans le même temps opératoire pour un rajeunissement global et harmonieux. Ces associations sont discutées en consultation.

Combien de temps dure le résultat ?

Un lifting bien réalisé dure entre 8 et 12 ans. Il ne stoppe pas le vieillissement, mais le repousse dans le temps. Un deuxième lifting peut être envisagé si nécessaire après ce délai.

Les cicatrices seront-elles visibles ?

Les cicatrices sont soigneusement tracées dans les zones naturellement dissimulées : creux temporal dans les cheveux, pli préauriculaire, contour du lobe, zone rétroauriculaire. Bien intégrées et bien soignées, elles deviennent quasiment imperceptibles en 6 à 12 mois.

Rhinoplastie — Chirurgie esthétique du nez

Tunis

La rhinoplastie est l'une des interventions de chirurgie esthétique du visage les plus complexes et les plus demandées. Elle permet de remodeler le nez pour le rendre plus harmonieux avec l'ensemble du visage : corriger une bosse, affiner la pointe, réduire les narines, corriger une déviation, améliorer un profil. Elle peut également corriger une obstruction nasale fonctionnelle (septorhinoplastie). Réalisée à Tunis par une chirurgienne formée aux techniques les plus modernes — préservation rhinoplasty, approche structurale, reconstruction par greffes cartilagineuses — elle exige une précision et un sens esthétique que j'ai développés tout au long de ma formation.

1h30–3h Durée	Générale Anesthésie	1 nuit Hospitalisation	12–18 mois Résultat définitif
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---

01 QU'EST-CE QUE LA RHINOPLASTIE ?

La rhinoplastie est une intervention chirurgicale qui remodèle la pyramide nasale en agissant sur ses différentes composantes : la charpente osseuse (os propres du nez), le cartilage (septal, latéraux, alaires) et le revêtement cutané. Le résultat doit être harmonieux avec l'ensemble du visage — un nez qui s'intègre naturellement sans attirer le regard.

Je pratique principalement la rhinoplastie de préservation (preservation rhinoplasty), technique moderne qui conserve au maximum les structures anatomiques natives plutôt que de les réséquer. Cette approche donne des résultats plus naturels, préserve mieux le soutien de la pointe nasale et réduit le risque de séquelles à long terme.

Rhinoplastie de préservation vs rhinoplastie structurale : la rhinoplastie de préservation est la technique moderne de référence — elle préserve le cartilage et repose, retourne et repositionne les structures plutôt que de les réduire. La rhinoplastie structurale (avec greffes) est indiquée pour les nez complexes nécessitant une reconstruction ou une reprise après une première chirurgie.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Nez disproportionné par rapport au reste du visage — bosse dorsale, pointe tombante ou bulbeuse
- Déviation de la pyramide nasale, asymétrie visible
- Narines larges ou asymétriques
- Obstruction nasale fonctionnelle liée à une déviation septale (septorhinoplastie)
- Séquelles d'une rhinoplastie antérieure insatisfaisante — rhinoplastie secondaire
- Croissance nasale terminée (à partir de 17–18 ans)

La rhinoplastie est l'intervention du visage dont le résultat définitif est le plus long à apprécier : 12 à 18 mois sont nécessaires pour que l'œdème résiduel se résorbe entièrement, surtout sur les peaux épaisses. Des attentes réalistes et une bonne compréhension de cette temporalité sont indispensables avant toute décision.

03 LA CONSULTATION

La consultation en rhinoplastie est particulièrement approfondie. J'analyse l'ensemble du visage en face et de profil : le rapport nez/menton (profiloplastie), la projection nasale, la rotation de la pointe, l'angle naso-labial, la largeur des narines, l'épaisseur cutanée et la qualité du revêtement. Des photographies standardisées sont prises.

Nous discutons de vos objectifs précis — une bosse à corriger, une pointe à affiner, un profil à harmoniser. Je vous explique ce qui est techniquement réalisable, les limites liées à votre anatomie (notamment l'épaisseur de la peau), et la technique la mieux adaptée à votre cas.

Une génioplastie (chirurgie du menton) peut être associée à la rhinoplastie dans le cadre d'une profiloplastie — pour équilibrer le profil facial. Un menton fuyant et un nez proéminent se corrigent souvent ensemble, avec un résultat global bien plus harmonieux que la correction isolée du nez.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique et consultation anesthésique
- **Tabac** : Arrêt du tabac au moins 1 mois avant
- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant
- **Jeûne** : Jeûne à partir de minuit la veille
- **Lunettes** : Pas de lunettes pendant 4 à 6 semaines après l'intervention (appui sur le dos du nez déconseillé)
- **Organisation** : Prévoir un accompagnateur pour le retour — conduite déconseillée 10 jours

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

La rhinoplastie est réalisée sous anesthésie générale. Deux voies d'abord sont possibles : la voie ouverte (incision sur la columelle, exposant toute la charpente nasale — indiquée pour les cas complexes et les reprises) et la voie fermée (incisions entièrement intranasales, sans cicatrice visible — pour les corrections moins étendues).

Selon la technique choisie, les gestes peuvent inclure : l'abaissement ou la résection de la bosse osseuse et cartilagineuse, le remodelage de la pointe par sutures (alar spanning, dome binding), la correction du septum en cas de déviation, la réduction des narines par une résection à leur base, et l'apport de greffes cartilagineuses (septales, conchal ou costales) pour soutenir ou reconstruire.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- 1 nuit en clinique
- Attelle nasale portée 10 à 14 jours
- Mèches endonasales retirées à J2
- Arrêt de travail de 10 à 15 jours
- Éviter tout sport de contact et exposition solaire pendant 3 mois
- Pas de lunettes pendant 4 à 6 semaines

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J3	Obstruction nasale liée aux mèches. Ecchymoses péri-orbitaires, œdème important. Tête surélevée. Respiration buccale.
Semaine 1–2	Ablation des mèches à J2, de l'attelle à J10–J14. Régression des ecchymoses. Nez encore gonflé mais résultat visible.
Semaine 2–4	Reprise de la vie sociale. L'œdème régresse progressivement. Le nez se précise.
Mois 1–3	Disparition de la majeure partie de l'œdème. Le résultat s'affine progressivement.
Mois 6–18	L'œdème résiduel (surtout de la pointe) se résorbe très lentement. Résultat définitif à 12–18 mois.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le résultat de la rhinoplastie est le plus lent à apprécier de toutes les interventions de chirurgie esthétique. L'œdème de la pointe peut persister 12 à 18 mois, surtout sur les peaux épaisses. Il faut de la patience — et faire confiance au processus.

Le résultat définitif est permanent. Le nez conservera sa nouvelle forme pour la vie, avec un vieillissement physiologique normal (la pointe peut s'affaisser très légèrement avec les décennies). La cicatrice columellaire (voie ouverte) devient imperceptible en 6 à 12 mois.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX	RISQUES SPÉCIFIQUES
– Hématome – Infection – Réaction anesthésique – Obstruction nasale transitoire	– Asymétrie résiduelle ou insuffisance de correction – Irrégularité ou perceptibilité de la dorsale nasale – Affaissement de la pointe nasale – Cicatrice columellaire visible (voie ouverte) – Résultat insatisfaisant nécessitant une reprise (10–15% des cas) – Modification de la voix ou de l'olfaction (rare et transitoire)

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

Quand peut-on apprécier le résultat définitif d'une rhinoplastie ?

À 12 à 18 mois, une fois l'œdème entièrement résorbé. La pointe est la dernière zone à dégonfler, surtout sur les peaux épaisses. Il est important de ne pas juger le résultat avant ce délai.

La rhinoplastie modifie-t-elle la voix ?

Une légère modification de la résonance vocale est possible dans les premières semaines, liée à l'œdème endonasal. Elle est transitoire et disparaît avec la cicatrisation. Une modification durable de la voix est exceptionnelle.

Peut-on corriger une rhinoplastie ratée ?

Oui — c'est la rhinoplastie secondaire ou de reprise. Elle est techniquement plus complexe car les tissus sont remaniés, souvent fibreux. Je la pratique régulièrement, notamment par approche structurelle avec greffes cartilagineuses. Un délai d'au moins 12 mois après la première intervention est nécessaire avant d'envisager une reprise.

Quelle est la différence entre rhinoplastie et septoplastie ?

La septoplastie est une intervention fonctionnelle qui corrige une déviation du septum nasal pour améliorer la respiration — sans modifier l'aspect extérieur du nez. La rhinoplastie est une intervention esthétique. La septorhinoplastie combine les deux objectifs dans le même temps opératoire.

La rhinoplastie est-elle douloureuse ?

Non. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale. Les suites sont marquées par une gêne, une obstruction nasale et des ecchymoses — mais les douleurs sont généralement légères et bien contrôlées par les antalgiques prescrits.

Blépharoplastie — Chirurgie des paupières Tunis

La blépharoplastie est la chirurgie des paupières — l'une des interventions de rajeunissement facial les plus efficaces et les plus demandées. Elle permet de corriger les paupières tombantes, les poches sous les yeux, et l'excès de peau qui donne un regard fatigué, vieilli ou triste. Discrète, précise, avec des résultats immédiats et durables, la chirurgie des paupières redonne au regard son éclat naturel. Elle peut être réalisée sur les paupières supérieures, inférieures, ou les quatre à la fois.

45min–1h30 Durée	Locale ou générale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	1–3 mois Résultat définitif
----------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LA BLÉPHAROPLASTIE ?

La blépharoplastie consiste à corriger les anomalies des paupières liées au vieillissement ou à l'hérédité. Sur les paupières supérieures, elle traite l'excès de peau (dermatochalasis), les poches graisseuses internes, et le ptosis (chute de la paupière par faiblesse du muscle releveur). Sur les paupières inférieures, elle traite les poches à graisse (graisses herniées) et les cernes creux.

On distingue deux techniques pour les paupières inférieures : la voie cutanée (incision sous le cil, pour les cas avec excès cutané associé) et la voie transconjonctivale (incision à l'intérieur de la paupière, sans cicatrice visible — idéale pour les jeunes patients ayant des poches sans excès cutané).

La blépharoplastie est souvent associée au lifting cervico-facial pour un rajeunissement global du visage, ou à un lipofilling des creux palpébraux (cernes creux) pour un résultat plus complet et plus naturel.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Paupières supérieures tombantes donnant un regard lourd ou triste
- Excès de peau supérieure gênant le champ visuel (indication fonctionnelle)
- Poches à graisse sous les yeux persistantes malgré le repos
- Cernes creux ou sillons lacrymo-jugaux marqués (lipofilling associé)
- Ptosis (paupière tombante par faiblesse musculaire) — correction du muscle releveur

Avant toute blépharoplastie inférieure, un test de Schirmer (mesure de la sécrétion lacrymale) et une évaluation du tonus palpébral sont recommandés. Un œil sec sévère ou un tonus palpébral insuffisant peuvent contre-indiquer certaines techniques. Ces éléments sont évalués en consultation.

03 LA CONSULTATION

L'examen clinique évalue l'excès cutané de chaque paupière, la quantité et la localisation des poches graisseuses, la tonicité du muscle orbiculaire, la présence d'un ptosis associé, et la

qualité du film lacrymal. L'asymétrie entre les deux côtés est analysée avec précision. Le projet chirurgical est établi ensemble, avec une explication détaillée de la technique, des cicatrices et du résultat attendu.

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique et consultation anesthésique (si anesthésie générale)
- **Tabac** : Arrêt du tabac au moins 1 mois avant
- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant — risque d'hématome majoré
- **Jeûne** : Jeûne à partir de minuit si anesthésie générale — pas nécessaire si anesthésie locale pure
- **Lentilles** : Enlever les lentilles de contact avant l'intervention et les 2 semaines suivantes
- **Maquillage** : Éviter le maquillage les yeux le jour de l'intervention

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

Blépharoplastie supérieure : réalisée sous anesthésie locale avec ou sans sédation, elle dure 45 minutes à 1 heure. L'incision est tracée dans le pli naturel de la paupière supérieure, invisible à l'ouverture de l'œil. L'excès cutané est réséqué avec précision, les poches graisseuses retirées ou redistribuées, et la fermeture réalisée avec des sutures très fines. En cas de ptosis, une plication du muscle releveur est réalisée dans le même temps.

Blépharoplastie inférieure par voie transconjonctivale : l'incision est réalisée à l'intérieur de la paupière, sans cicatrice visible. Les poches graisseuses sont retirées ou redistribuées dans le sillon lacrymo-jugal. Un lipofilling peut être associé pour corriger les creux. Cette technique est idéale pour les patients jeunes sans excès cutané.

Blépharoplastie inférieure par voie cutanée : l'incision sous-ciliaire (dans le pli sous les cils) permet de réséquer l'excès de peau en association avec le traitement des poches. Elle est indiquée en cas de dermatochalasis inférieur associé.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire dans tous les cas — retour à domicile le jour même
- Arrêt de travail de 7 à 10 jours
- Compresses froides les premières 48 heures
- Collyre lubrifiant prescrit les 2 premières semaines
- Éviter l'écran et la lecture les 3 premiers jours
- Protection solaire des cicatrices pendant 3 mois

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J3 Ecchymoses et œdème palpébraux, larmoiement possible. Compresses froides. Collyres lubrifiants.

Semaine 1	Ablation des fils vers J5–J7. Régression rapide des ecchymoses. Reprise d'un travail de bureau possible.
Semaine 2–3	Disparition des ecchymoses. L'œil reprend son éclat. Maquillage possible dès J7–J10.
Mois 1–3	Cicatrices qui s'estompent progressivement. Résultat définitif apprécié à 1–3 mois.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Les résultats de la blépharoplastie sont parmi les plus immédiats et les plus spectaculaires de la chirurgie esthétique du visage. Dès la première semaine, le regard est ouvert, reposé, rajeuni. Le résultat définitif s'apprécie à 1 à 3 mois. Les cicatrices supérieures deviennent invisibles dans le pli naturel. Les cicatrices inférieures sous-ciliaires sont imperceptibles en 3 à 6 mois.

La durabilité est excellente : 8 à 15 ans selon l'âge, la qualité cutanée et le vieillissement individuel. Les poches graisseuses retirées ne récidivent pas. Un excès cutané peut se reformer avec les années — une retouche limitée est alors possible.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX	RISQUES SPÉCIFIQUES
– Hématome palpébral – Infection – Réaction anesthésique – Larmolement transitoire	– Lagophtalmie (fermeture incomplète) — transitoire si résection cutanée modérée – Sécheresse oculaire (aggravation d'un syndrome préexistant) – Cicatrice visible ou hypertrophique – Asymétrie résiduelle – Ectropion inférieur (retournement de la paupière — rare, prévenu par le test de tonus) – Diplopie transitoire (vision double — très rare)

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

La blépharoplastie change-t-elle la forme des yeux ?

Non. L'objectif est de corriger l'excès cutané et les poches sans modifier la forme ni l'expression du regard. Une blépharoplastie bien réalisée donne un œil plus ouvert et reposé — pas un œil différent.

Peut-on opérer les 4 paupières en même temps ?

Oui, les quatre paupières peuvent être traitées dans le même temps opératoire. C'est fréquemment proposé pour un résultat global harmonieux du regard.

La blépharoplastie est-elle prise en charge ?

La blépharoplastie supérieure peut être fonctionnelle (champ visuel réduit par les paupières tombantes) et prise en charge partiellement dans certains systèmes de santé. En Tunisie, la chirurgie est réalisée dans un cadre privé. Un devis détaillé vous est remis en consultation.

Peut-on porter des lentilles après une blépharoplastie ?

Les lentilles sont déconseillées pendant les 2 premières semaines. Elles peuvent ensuite être reprises progressivement, selon l'évolution de la sécheresse oculaire post-opératoire.

Otoplastie — Chirurgie des oreilles décollées

Tunis

L'otoplastie, ou chirurgie des oreilles décollées, est une intervention simple et efficace qui permet de corriger définitivement des oreilles trop écartées du crâne ou trop grandes. Source de complexes dès l'enfance, les oreilles décollées peuvent être corrigées chirurgicalement à partir de 6–7 ans. Chez l'adulte, l'intervention reste identique et donne des résultats permanents. C'est l'une des rares chirurgies esthétiques réalisable sous anesthésie locale, avec une convalescence rapide et un impact psychologique très positif.

1–1h30 Durée	Locale ou générale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	3–6 sem. Convalescence
------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

01 QU'EST-CE QUE L'OTOPLASTIE ?

L'otoplastie corrige le défaut anatomique responsable du décollement des oreilles : l'absence ou l'insuffisance du pli de l'anthélix (le repli cartilagineux interne du pavillon), et/ou la profondeur excessive de la conque (la cavité centrale du pavillon). Par une incision discrète derrière l'oreille, le cartilage est remodelé par des sutures permanentes pour créer ou renforcer le pli de l'anthélix et réduire la conque, rapprochant l'oreille du crâne.

Le résultat est symétrique, naturel, et permanent. L'objectif n'est pas d'obtenir des oreilles parfaitement « plaquées » mais des oreilles harmonieuses, en équilibre avec le reste du visage.

02 ÊTES-VOUS UN(E) BON(NE) CANDIDAT(E) ?

- Oreilles décollées de façon symétrique ou asymétrique
- Anthélix insuffisamment marqué — oreille manquant de galbe
- Conque trop profonde — oreille en décollement global
- Enfant de 6–7 ans minimum (cartilage suffisamment stable)
- Adulte souhaitant corriger un complexe existant depuis l'enfance

L'otoplastie peut être réalisée dès l'âge de 6–7 ans, lorsque le cartilage auriculaire a atteint 85 à 90% de son volume adulte. Chez l'enfant, l'intervention est réalisée sous anesthésie générale. Chez l'adulte, une anesthésie locale avec légère sédation est généralement suffisante.

03 LA CONSULTATION

L'examen clinique évalue l'angle auriculo-céphalique (angle entre l'oreille et la tête, normalement entre 25 et 35 degrés), la position et la taille des deux oreilles, l'état du cartilage et la symétrie. Le plan chirurgical est individualisé : technique de remodelage cartilagineux, sutures utilisées, geste éventuel sur la conque. Des photographies standardisées sont prises.

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention. Pour les patients mineurs, l'accord des deux parents est requis.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique et consultation anesthésique
- **Tabac** : Arrêt du tabac 1 mois avant si adulte fumeur
- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant
- **Jeûne** : Jeûne à partir de minuit si anesthésie générale
- **Cheveux** : Cheveux propres le jour de l'intervention — éviter les barrettes ou bijoux dans les cheveux

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'otoplastie dure entre 1 heure et 1h30. L'incision est tracée dans le sillon postérieur de l'oreille, entièrement cachée derrière le pavillon. Après exposition du cartilage, la technique de Mustardé (sutures de remodelage de l'anthélix) et/ou la technique de Furnas (sutures de réduction de la conque) sont appliquées selon les besoins anatomiques. Les sutures utilisées sont permanentes pour garantir la durabilité du résultat. La fermeture est réalisée par sutures résorbables.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire — retour à domicile le jour même
- Bandeau auriculaire porté 1 semaine en continu, puis la nuit pendant 1 mois
- Arrêt de travail de 5 à 7 jours
- Éviter tout traumatisme des oreilles pendant 2 mois
- Éviter les sports de contact pendant 2 mois

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J5	Léger œdème et ecchymoses autour des oreilles. Bandeau en place. Douleurs légères bien contrôlées.
Semaine 1–2	Ablation des fils vers J10–J14. L'œdème régresse. Le résultat se précise progressivement.
Semaine 2–6	Port du bandeau la nuit uniquement. Reprise des activités normales. Sport léger possible dès S3.
Mois 1–3	Résultat définitif. Cicatrice invisible derrière l'oreille. Oreilles harmonieuses et symétriques.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le résultat est immédiatement visible dès le retrait du bandeau : les oreilles sont rapprochées, galonnées, symétriques. L'appréciation définitive se fait à 3 mois. La durabilité est excellente — les sutures permanentes garantissent un résultat stable dans le temps. La cicatrice, derrière l'oreille, est quasiment invisible.

Le bénéfice psychologique, notamment chez l'enfant, est souvent profond et immédiat — libération d'un complexe qui pouvait affecter la vie sociale et scolaire.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX

- Hématome post-opératoire
- Infection superficielle
- Réaction anesthésique

RISQUES SPÉCIFIQUES

- Récidive partielle du décollement (sutures qui lâchent)
- Asymétrie résiduelle
- Hypercorrection (oreilles trop plaquées)
- Cicatrice élargie ou chéloïde derrière l'oreille
- Hypo-sensibilité du pavillon (transitoire)

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

À quel âge peut-on opérer un enfant ?

À partir de 6–7 ans, quand le cartilage auriculaire est suffisamment mature et stable. Il est souvent conseillé d'opérer avant l'entrée en primaire ou au début du collège pour épargner à l'enfant les moqueries. L'accord des deux parents est requis.

Le résultat est-il permanent ?

Oui. Les sutures permanentes utilisées garantissent la stabilité du résultat dans le temps. Une récurrence est possible mais rare — elle est liée à une rupture de suture ou à une correction insuffisante initiale.

L'intervention est-elle douloureuse ?

Les douleurs post-opératoires sont légères et bien contrôlées par des antalgiques simples. Une légère sensation de tension ou de tiraillement les premiers jours est normale et transitoire.

Y a-t-il une cicatrice visible ?

La cicatrice est tracée dans le sillon postérieur de l'oreille — entièrement cachée derrière le pavillon. Elle est quasiment invisible, même cheveux relevés.

Lipoaspiration du cou — Double menton chirurgie Tunis

La lipoaspiration du cou, ou liposuccion cervicale, est l'intervention indiquée pour corriger le double menton et redéfinir l'angle cervico-mentonnier. Lorsque la graisse cervicale est abondante et localisée, résistant au sport et au régime, la lipoaspiration cervicale permet de retrouver en une intervention courte et peu invasive un profil harmonieux et un cou affiné. Elle peut être réalisée seule ou associée à un lifting cervico-facial pour une correction complète.

30–45 min Durée	Locale ou générale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	2–3 mois Résultat définitif
---------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LA LIPOASPIRATION DU COU ?

La lipoaspiration cervicale consiste à aspirer la graisse localisée sous le menton et dans la région cervicale antérieure, à l'aide de micro-canules introduites par une ou deux micro-incisions sous le menton et derrière les lobes d'oreilles. Elle permet de redéfinir l'angle cervico-mentonnier (l'angle entre la gorge et le profil du menton), qui donne sa noblesse au profil facial.

Elle est efficace chez les sujets jeunes avec une bonne élasticité cutanée, qui permettra une bonne rétraction de la peau après aspiration. Chez les patients plus âgés avec un relâchement cutané associé, une lipoaspiration seule peut être insuffisante — un lifting cervico-facial est alors préférable.

02 ÊTES-VOUS UN(E) BON(NE) CANDIDAT(E) ?

- Double menton persistant malgré une perte de poids
- Graisse cervicale localisée disproportionnée avec le reste du visage
- Bonne élasticité cutanée cervicale — peau capable de se rétracter après aspiration
- Poids stable

La lipoaspiration du cou seule n'est pas indiquée en cas de relâchement cutané cervical significatif — la peau excédentaire ne se rétractera pas suffisamment après aspiration et le résultat serait insatisfaisant. Dans ce cas, un lifting cervico-facial avec ou sans lipoaspiration est l'indication appropriée.

03 LA CONSULTATION

L'examen clinique évalue la quantité de graisse cervicale, la qualité et l'élasticité cutanée, et la présence ou non d'un relâchement musculaire des muscles peauciers (bands platysmal). Selon ces éléments, je vous propose la solution la plus adaptée : lipoaspiration seule, lipoaspiration avec plastysmaplastie (resserrement du muscle platysma par voie sous-mentale), ou lifting cervico-facial associé.

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique si anesthésie générale — pas nécessaire pour anesthésie locale
 - **Tabac** : Arrêt du tabac 1 mois avant
 - **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant
 - **Jeûne** : Jeûne si anesthésie générale
 - **Contention** : Prévoir un bandeau cervical de contention sur prescription
-

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'intervention est réalisée sous anesthésie locale ou générale et dure 30 à 45 minutes. Une ou deux micro-incisions de 2 à 3 mm sont pratiquées sous le menton (et parfois derrière les lobes d'oreilles pour les zones latérales). Après infiltration tumescente, les micro-canules aspirent la graisse cervicale de façon progressive et homogène. Si un relâchement du platysma est associé, une plicature musculaire (plastymaplastie) peut être réalisée par la même voie.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire — retour à domicile le jour même
 - Bandeau cervical de contention porté 3 à 4 semaines
 - Arrêt de travail de 5 à 7 jours
 - Éviter l'exposition solaire cervicale pendant 3 mois
-

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J5	Ecchymoses et légère induration cervicale. Bandeau en place. Douleurs légères.
Semaine 1–3	Régression des ecchymoses. L'œdème résiduel se résorbe. Le profil commence à se dessiner.
Mois 1–3	Disparition de l'œdème. Résultat définitif visible. L'angle cervico-mentonnier est redéfini.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le résultat définitif s'apprécie à 2 à 3 mois : le profil est affiné, l'angle cervico-mentonnier nettement redéfini, le cou harmonieux. Les micro-cicatrices sont imperceptibles. La durabilité est bonne à poids stable — les cellules graisseuses aspirées ne se reconstituent pas.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX	RISQUES SPÉCIFIQUES
– Hématome cervical – Infection – Réaction anesthésique	– Irrégularité de surface cervicale – Rétraction cutanée insuffisante – Hypo-sensibilité cutanée transitoire

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">– Asymétrie– Récidive si prise de poids ultérieure |
|--|---|

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

La lipoaspiration du cou peut-elle remplacer un lifting ?

Chez les sujets jeunes avec une bonne élasticité cutanée, oui. Chez les patients plus âgés avec un relâchement cutané, la lipoaspiration seule donnera un résultat insuffisant — un lifting cervico-facial est plus approprié. L'évaluation clinique en consultation tranche.

Le double menton peut-il revenir après l'opération ?

Les cellules graisseuses aspirées sont définitivement éliminées. En revanche, une prise de poids importante peut reconstituer du tissu graisseux dans les zones non aspirées. Un poids stable est la condition de la pérennité du résultat.

Lipofilling du visage — Rajeunissement par greffe de graisse Tunis

Le lipofilling du visage, également appelé transfert de graisse autologue ou lipostructure faciale, est une technique de rajeunissement et de restauration des volumes du visage utilisant la propre graisse du patient. Il permet de corriger les creux et les pertes de volume liés au vieillissement — cernes, tempes creuses, pommettes, sillons nasogéniens, lèvres — sans corps étranger, avec un résultat naturel et durable. Il peut être réalisé seul ou associé à un lifting, une rhinoplastie, ou une blépharoplastie.

1–2h Durée	Locale ou générale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	4–6 mois Résultat définitif
----------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LE LIPOFILLING DU VISAGE ?

Le vieillissement du visage n'est pas seulement une affaire de relâchement cutané — c'est aussi une perte de volume progressive. Les pommettes s'aplatissent, les tempes se creusent, les cernes apparaissent, les sillons nasogéniens se marquent. Le lipofilling facial restaure ces volumes en injectant de la graisse autologue (prélevée dans une zone donneuse comme l'abdomen ou les flancs) dans les zones déficitaires.

La graisse utilisée est la vôtre — pas d'implant, pas d'acide hyaluronique. Le résultat est naturel au toucher, intégré aux tissus, et durable. Une partie de la graisse injectée sera résorbée (30 à 40%) — le volume final s'apprécie à 4 à 6 mois.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Creux cernaux ou cernes creux marqués résistant aux soins
- Fonte des pommettes et perte de volume du milieu du visage
- Tempes creuses donnant un aspect vieilli ou marqué
- Sillons nasogéniens profonds
- Lèvres fines souhaitant un volume naturel (sans acide hyaluronique)
- Asymétrie faciale volumique

03 LA CONSULTATION

L'analyse volumique du visage est réalisée en trois dimensions : face, profil et trois-quarts. Les zones déficitaires sont identifiées et hiérarchisées. Le volume de graisse à injecter par zone est estimé, ainsi que les zones donneuses disponibles. Je vous explique les volumes injectés, le taux de résorption attendu et le résultat final prévisible.

Le lipofilling du visage peut être associé à un lifting cervico-facial pour traiter simultanément le relâchement et la perte de volume — les deux composantes du vieillissement facial. Cette association donne les résultats les plus complets et les plus naturels.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique si anesthésie générale
 - **Tabac** : Arrêt du tabac 1 mois avant
 - **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant
 - **Jeûne** : Jeûne si anesthésie générale ou sédation
 - **Contention** : Gaine de contention légère sur la zone donneuse
-

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'intervention se déroule en trois temps. Premièrement, le prélèvement de graisse par lipoaspiration douce dans la zone donneuse, avec une canule fine pour préserver la viabilité des cellules adipeuses. Deuxièmement, la purification de la graisse par centrifugation selon la technique de Coleman. Troisièmement, la réinjection en micro-bolus dans les différentes zones du visage, couche par couche, avec des micro-canules très fines pour une intégration homogène et naturelle.

La précision de la réinjection est fondamentale : trop en superficie → nodules visibles ; trop en profondeur → mauvaise vascularisation et résorption excessive. La technique de Coleman, utilisée en micro-bolus dans plusieurs plans, est celle qui donne les résultats les plus homogènes et les plus durables.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire — retour à domicile le jour même
 - Arrêt de travail de 7 à 10 jours (ecchymoses faciales)
 - Gaine légère sur la zone donneuse pendant 3 semaines
 - Éviter tout massage facial les 3 premières semaines
 - Protection solaire stricte pendant 3 mois
-

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J5	Ecchymoses et œdème facial importants. Le visage paraît gonflé et irrégulier — normal à ce stade.
Semaine 1–2	Régression des ecchymoses. L'œdème diminue progressivement. Le résultat commence à apparaître.
Mois 1–2	La graisse s'intègre et la résorption partielle se stabilise. Le volume final se précise.
Mois 3–6	Résultat définitif. La graisse survivante est permanente.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Environ 60 à 70% de la graisse injectée persiste durablement. Les zones traitées retrouvent leur volume, les creux sont comblés, les sillons atténués. Le résultat est naturel, souple, et évolue avec le vieillissement physiologique — contrairement aux résultats des fillers d'acide hyaluronique.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX

- Hématome dans la zone donneuse
- Infection
- Réaction anesthésique

RISQUES SPÉCIFIQUES

- Résorption supérieure à 40% — retouche éventuelle à 6 mois
- Nodules graisseux (cytostéatonécrose)
- Asymétrie résiduelle
- Irrégularités de surface si réinjection superficielle
- Embolie graisseuse (exceptionnelle si règles techniques respectées)

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

Le lipofilling dure-t-il plus longtemps que l'acide hyaluronique ?

Oui. L'acide hyaluronique se résorbe en 12 à 18 mois selon les zones. La graisse autologue, une fois intégrée, est permanente — la graisse survivante après 6 mois ne se résorbe plus. Le lipofilling est une solution plus durable mais plus invasive.

Peut-on combiner lipofilling et lifting ?

Oui, c'est même souvent recommandé. Le lifting traite le relâchement, le lipofilling restaure les volumes — ensemble, ils traitent les deux composantes du vieillissement facial pour un résultat global et naturel.

Lip lift — Remontée de la lèvre supérieure Tunis

Le lip lift est une intervention chirurgicale discrète qui permet de raccourcir la distance entre la base du nez et le bord rouge de la lèvre supérieure (philtrum), tout en augmentant le volume et l'éversion de la lèvre. Il corrige l'allongement progressif du philtrum lié au vieillissement, qui donne à la bouche un aspect tombant, effacé et vieilli. Le lip lift offre un résultat naturel et permanent — bien différent d'une simple injection d'acide hyaluronique qui augmente le volume sans raccourcir le philtrum.

30–45 min Durée	Locale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	3–6 mois Résultat définitif
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LE LIP LIFT ?

Le lip lift consiste à réséquer une bande de peau elliptique sous la base du nez (incision en « ailes de mouette » ou bull horn), ce qui remonte mécaniquement la lèvre supérieure, raccourcit le philtrum, augmente la projection de la lèvre et expose davantage le vermillon. Le résultat est une bouche plus jeune, plus pulpeuse, plus expressive — sans l'aspect artificiel des lèvres trop injectées.

La cicatrice est tracée dans la zone de jonction entre la peau et la base du nez — elle suit le contour des ailes du nez et est quasiment imperceptible en 6 à 12 mois.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Philtrum allongé (distance nez–lèvre supérieure > 15–17 mm)
- Lèvre supérieure plate ou effacée — vermillon peu visible
- Bouche vieillissante avec perte de la courbe de Cupidon
- Souhait d'un résultat naturel et permanent, différent des injections

Le lip lift et les injections d'acide hyaluronique sont complémentaires : le lip lift raccourcit et remonte la lèvre (action structurelle), tandis que les injections augmentent le volume (action volumique). Les deux peuvent être combinés pour un résultat optimal.

03 LA CONSULTATION

La consultation évalue la distance philtrum, la hauteur et la projection de la lèvre supérieure, la symétrie, la qualité cutanée et les attentes. Le tracé prévu de la cicatrice est discuté et expliqué. La quantité de peau à réséquer est calculée avec précision — une résection insuffisante donne un résultat décevant, une résection excessive donne une lèvre trop « retroussée ».

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant

- **Tabac** : Arrêt du tabac 1 mois avant — cicatrisation de la lèvre supérieure exigeante
- **Maquillage** : Pas de maquillage le jour de l'intervention
- **Jeûne** : Pas de jeûne nécessaire pour anesthésie locale pure

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'intervention est réalisée sous anesthésie locale et dure 30 à 45 minutes. Après marquage précis au stylo dermatographique, une bande elliptique de peau est réséquée sous la base du nez, suivant la technique « bull horn » (les extrémités de l'ellipse remontent dans les ailes du nez pour que la cicatrice disparaisse dans la jonction aile-joue). La fermeture est réalisée au fil fin résorbable et non résorbable, avec une attention particulière à la tension et à la qualité de la suture.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire — retour à domicile immédiat
- Arrêt de travail de 5 à 7 jours
- Éviter les mouvements amples de la bouche (rire, bâillements) les 10 premiers jours
- Alimentation semi-liquide les 3 premiers jours
- Protection solaire stricte de la cicatrice pendant 6 mois

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J5	Ecchymose et légère induration de la lèvre supérieure. Cicatrice sous le nez. Alimentation adaptée.
Semaine 1–2	Ablation des fils vers J7. La lèvre se dégonfle. Le résultat commence à apparaître.
Semaine 2–6	Assouplissement de la cicatrice. Massage cicatriciel prescrit. La lèvre se stabilise.
Mois 1–6	Maturation de la cicatrice. Résultat définitif à 3–6 mois. Cicatrice devenant imperceptible.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le résultat du lip lift est permanent et naturel : la lèvre supérieure est plus haute, plus pulpeuse, avec un vermillon plus exposé et une courbe de Cupidon mieux dessinée. La cicatrice, bien que visible les premières semaines, devient quasiment imperceptible dans la zone de jonction sous-nasale en 6 à 12 mois.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX	RISQUES SPÉCIFIQUES
– Infection superficielle – Hématome – Cicatrisation retardée	– Cicatrice visible ou hypertrophique sous le nez – Asymétrie de la courbe de Cupidon – Hypercorrection — lèvre trop retroussée

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">– Résultat insuffisant — philtrum encore long– Modification de l'odorat (très rare) |
|--|--|

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

Le lip lift remplace-t-il les injections de lèvres ?

Non — les deux interventions agissent différemment. Le lip lift raccourcit le philtrum et remonte la lèvre (effet structurel permanent). Les injections d'acide hyaluronique augmentent le volume (effet volumique temporaire). Ils sont complémentaires plutôt que substituables.

La cicatrice est-elle visible ?

Les premières semaines, la cicatrice est visible sous le nez. Elle s'estompe progressivement et devient quasiment imperceptible à 6–12 mois dans la zone de transition cutanée-nasale. Une cicatrice fine et bien soignée passe inaperçue à distance normale.

Lifting temporal — Remontée des sourcils et de la queue de l'œil Tunis

Le lifting temporal est une intervention ciblée qui agit sur le tiers latéral du visage : il remonte la queue du sourcil, corrige le relâchement de la tempe et de la région péri-orbitaire externe, et redéfinit le regard. Moins étendu qu'un lifting frontal complet, il est indiqué lorsque les signes de vieillissement sont localisés à la région temporale — sourcil qui descend, regard alourdi par les tempes, coin de l'œil qui s'affaisse. Il peut être réalisé seul ou associé à un lifting cervico-facial.

45min–1h Durée	Locale ou générale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	2–3 mois Résultat définitif
--------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LE LIFTING TEMPORAL ?

Le lifting temporal consiste à soulever et retendre les tissus de la région temporale par une incision dissimulée dans le cuir chevelu temporal. Il agit sur la queue du sourcil (remontée latérale), le coin externe de l'œil (canthus externe), et la peau temporale relâchée. Il donne un regard plus ouvert, moins « plombé », et peut éviter ou retarder une blépharoplastie supérieure dans certains cas.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Queue du sourcil tombante donnant un regard triste ou fatigué
- Coin externe de l'œil (canthus) qui s'affaisse
- Relâchement cutané limité à la région temporale
- Souhait d'un geste ciblé et minimal — alternative au lifting frontal complet

03 LA CONSULTATION

L'examen analyse la position du sourcil (distance sourcil-bord orbitaire, symétrie), le degré de ptose temporale et la présence de rides péri-orbitaires associées. Le lifting temporal est souvent discuté en association avec une blépharoplastie supérieure (pour les cas où l'excès de peau de la paupière est aggravé par la chute du sourcil) ou un lifting cervico-facial.

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Tabac** : Arrêt du tabac 1 mois avant
- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant
- **Cheveux** : Shampoing la veille — pas de produits coiffants le jour de l'intervention
- **Jeûne** : Jeûne si anesthésie générale ou sédation

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'intervention dure 45 minutes à 1 heure. L'incision est tracée dans le cuir chevelu temporal, dissimulée dans les cheveux. Les tissus temporaux sont décollés et remis en tension vers le haut et l'arrière. L'excès cutané est réséqué et la fermeture réalisée avec soin. Le résultat est une remontée de la queue du sourcil et un dégagement du regard latéral.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire
 - Arrêt de travail de 7 à 10 jours
 - Éviter les shampooings vigoureux pendant 2 semaines
 - Exposition solaire du scalp évitée pendant 3 mois
-

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J5 Ecchymoses temporales légères. Sensation de tension dans la région temporale. Cicatrice dans les cheveux.

Semaine 1–2 Ablation des fils vers J10–J14. Régression de l'œdème et des ecchymoses.

Mois 1–3 Résultat définitif. Regard ouvert et rajeuni. Cicatrice invisible dans les cheveux.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le lifting temporal donne un regard plus ouvert, la queue du sourcil remontée, l'angle de l'œil redéfini. Le résultat s'apprécie à 2 à 3 mois et dure en moyenne 5 à 8 ans. La cicatrice est entièrement cachée dans le cuir chevelu.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX

- Hématome
- Infection superficielle
- Réaction anesthésique

RISQUES SPÉCIFIQUES

- Alopécie temporaire au niveau de la cicatrice
 - Asymétrie de la hauteur des sourcils
 - Hypo-sensibilité temporale transitoire
 - Récidive à moyen terme
 - Sourcil trop relevé — hypercorrection
-

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre lifting temporal et lifting frontal ?

Le lifting temporal agit uniquement sur la région temporale et la queue du sourcil. Le lifting frontal traite l'ensemble du front, des rides horizontales frontales et des sourcils. Le lifting temporal est une intervention plus ciblée, moins étendue, avec des suites plus légères.

Peut-on associer lifting temporal et blépharoplastie ?

Oui, et cette association est fréquente. La chute de la queue du sourcil aggrave le surplomb palpébral — en remontant le sourcil par un lifting temporal, on peut réduire la quantité de peau à réséquer à la paupière et améliorer le résultat global du regard.

Génomoplastie — Chirurgie du menton Tunis

La génomoplastie, ou mentoplastie, est la chirurgie de correction du menton. Elle permet d'augmenter un menton fuyant (microgénie), de réduire un menton proéminent, ou de corriger une asymétrie. Le menton joue un rôle fondamental dans l'harmonie du profil facial : un menton trop en retrait déséquilibre l'ensemble du visage et peut accentuer l'apparence d'un nez fort. La génomoplastie est souvent associée à une rhinomoplastie dans le cadre d'une profiloplastie globale — les deux corrections ensemble donnent un résultat harmonieux incomparable.

30–60 min Durée	Locale ou générale Anesthésie	Ambulatoire Hospitalisation	2–3 mois Résultat définitif
---------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

01 QU'EST-CE QUE LA GÉNIOPLASTIE ?

La génomoplastie peut être réalisée par deux techniques principales : par implant (augmentation du menton par prothèse en silicone solide — technique la plus courante pour les microgénies) ou par ostéotomie (avancement ou recul de la pointe du menton par découpe osseuse — technique plus complexe, indiquée pour les corrections importantes ou la réduction).

La génomoplastie par implant est réalisée par une incision intrabuccale (à l'intérieur de la bouche, sans cicatrice externe) ou par une incision sous-mentale (sous le menton, dans le pli naturel). La prothèse en silicone solide est glissée en avant de l'os et fixée.

02 ÊTES-VOUS UNE BONNE CANDIDATE ?

- Menton fuyant — microgénie — déséquilibrant le profil facial
- Profil facial avec un rapport nez/menton déséquilibré
- Asymétrie du menton visible de face
- Correction souhaitée dans le cadre d'une profiloplastie avec rhinomoplastie

Profiloplastie : l'analyse du profil facial montre souvent que nez et menton sont à corriger ensemble. Un menton fuyant accentue visuellement la taille du nez — en avançant le menton, on peut souvent réduire le geste chirurgical sur le nez ou le rendre inutile. La profiloplastie est une approche globale qui harmonise l'ensemble du profil.

03 LA CONSULTATION

L'analyse céphalométrique (mesures du profil facial) est réalisée sur photos standardisées : angle naso-labial, projection nasale, profil du menton, harmonie des tiers du visage. Le choix entre implant et ostéotomie est discuté selon l'importance de la correction souhaitée. Pour les augmentations de moins de 10 mm, l'implant donne d'excellents résultats. Au-delà, ou en cas de correction dans plusieurs plans de l'espace, l'ostéotomie est préférable.

Délai légal de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention.

04 PRÉPARATION & RECOMMANDATIONS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Bilan** : Bilan biologique et consultation anesthésique
- **Tabac** : Arrêt du tabac 1 mois avant
- **Médicaments** : Arrêt de l'aspirine et des AINS 10 jours avant
- **Antiseptique** : Bain de bouche antiseptique prescrit à commencer la veille (voie intrabuccale)
- **Jeûne** : Jeûne si anesthésie générale

05 L'INTERVENTION — TECHNIQUE & DÉROULEMENT

L'intervention est réalisée sous anesthésie locale ou générale et dure 30 à 60 minutes. Par voie intrabuccale : une incision dans le sulcus gingivolabial inférieur permet d'accéder à la loge prémentonnaire sans cicatrice externe. L'implant en silicone est glissé en avant de l'os mental et centré avec précision. Il est fixé par une suture ou une vis selon les cas.

Par voie sous-mentale : une incision de 1,5 à 2 cm dans le pli naturel sous le menton permet le même accès. Cette voie est préférée en cas de lipoaspiration du double menton associée ou si une cicatrice intrabuccale est à éviter.

06 HOSPITALISATION & ORGANISATION PRATIQUE

- Ambulatoire
- Arrêt de travail de 7 à 10 jours
- Bains de bouche antiseptiques 3 fois par jour pendant 15 jours (voie intrabuccale)
- Alimentation molle les 10 premiers jours
- Éviter les traumatismes du menton pendant 2 mois

07 SUITES OPÉRATOIRES & CONVALESCENCE

J1 – J5	Ecchymose et œdème du menton et de la lèvre inférieure. Sensation d'engourdissement transitoire.
Semaine 1–2	Régression des ecchymoses. Implant légèrement perceptible à la palpation. L'œdème diminue.
Mois 1–3	Disparition complète de l'œdème. L'implant s'intègre. Résultat définitif visible.

08 RÉSULTATS & ÉVOLUTION

Le résultat est naturel et harmonieux : le profil est équilibré, le menton projeté, le rapport nez/menton rétabli. L'implant en silicone solide est durable et ne nécessite pas de remplacement. Il est à peine perceptible à la palpation après quelques mois d'intégration.

09 RISQUES & COMPLICATIONS

RISQUES GÉNÉRAUX	RISQUES SPÉCIFIQUES
– Hématome	– Déplacement de l'implant

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Infection (ostéite — rare mais grave, nécessite l'ablation de l'implant) – Réaction anesthésique | <ul style="list-style-type: none"> – Résorption osseuse sous l'implant (minime, à long terme) – Hypo-sensibilité du menton ou de la lèvre inférieure (transitoire) – Asymétrie – Exposition de l'implant (voie intrabuccale — très rare) |
|---|--|

10 QUESTIONS FRÉQUENTES

La génioplastie par implant laisse-t-elle une cicatrice visible ?

Par voie intrabuccale, aucune cicatrice externe. Par voie sous-mentale, une cicatrice de 1,5 à 2 cm dans le pli naturel sous le menton — quasiment invisible à 6 mois.

L'implant de menton se sent-il au toucher ?

Légèrement les premières semaines, puis il s'intègre progressivement aux tissus environnants et devient imperceptible au toucher dans la grande majorité des cas.

Peut-on associer génioplastie et rhinoplastie ?

Oui, et cette association est souvent recommandée dans le cadre d'une profiloplastie. Les deux interventions sont réalisées dans le même temps opératoire pour harmoniser simultanément le nez et le menton. Le résultat global est souvent plus satisfaisant que la correction isolée de l'un ou l'autre.

L'implant dure-t-il toute la vie ?

Les implants en silicone solide sont conçus pour durer indéfiniment. Contrairement aux prothèses mammaires, ils n'ont pas de durée de vie fixe et ne nécessitent pas de remplacement systématique. Un suivi clinique périodique est suffisant.